

C

鎮咳薬，喀痰調整薬（去痰薬）

cough remedy, expectorant

到達目標

- ◆ 咳嗽の発生機序が説明できる
- ◆ 鎮咳薬の分類と適応が説明できる
- ◆ 喀痰の発生機序が説明できる
- ◆ 喀痰調整薬の分類と適応が説明できる

1 鎮咳薬と喀痰調整薬の使い方と適応

咳嗽診療の原則は，症状の背景にある病態や原因疾患を理解し，これらに対する特異的な治療を行うことである。こうした治療を十分行っても改善しない，あるいは有効な治療法がなく，咳嗽のために QOL が低下する場合に，症状緩和の目的で鎮咳薬の投与を検討する。喀痰診療も基本的には同様であるが，COPD や気管支拡張症などの慢性呼吸器疾患においては，症状緩和と病態改善の目的で喀痰調整薬が長期間投与される^{1,2)}。

咳嗽は，喀痰を伴う湿性咳嗽と喀痰を伴わない乾性咳嗽に分類される。湿性咳嗽の場合は，気道過分泌の病態が存在し，喀痰を喀出するために咳嗽が生じている。したがって，咳嗽を抑制することは，気道に分泌物が貯留し，気道閉塞や換気障害の原因となりうるため，湿性咳嗽における対症療法の基本は喀痰調整薬である。一方，乾性咳嗽においては，QOL を低下させる咳嗽の場合は鎮咳薬の投与を考慮する^{1,2)}。

2 鎮咳薬

a 咳嗽の発生機序

咳嗽とは，気道内に貯留した分泌物や異物を気道外に排除するための生体防御反応である。

咳嗽の発生には，迷走神経を求心路とする不随意的な咳嗽反射とさらに上位の脳（大脳など）が関与する随意的な咳嗽反応（咳衝動）が複雑に関与している（図 1）。生理的咳嗽反射では，気道壁表層の知覚神経終末（咳受容体）の刺激が，迷走神経を介して延髄咳中枢に伝達され，呼吸中枢と連携しながら肋間筋や横隔膜に遠心性の収縮刺激が送られ咳が発生する。生理的咳嗽を発生させる過剰刺激には，気道内分泌物や異物，刺激性ガスなどがある。一方，病的咳嗽反応には，咳受容体の感受性亢進を介する経路と気道平滑筋収縮を介する経路がある。さらに，中枢神経の関与も想定されている³⁾。

b 鎮咳薬の分類

鎮咳薬は中枢性鎮咳薬（麻薬性・非麻薬性）と末梢性鎮咳薬に分類される。

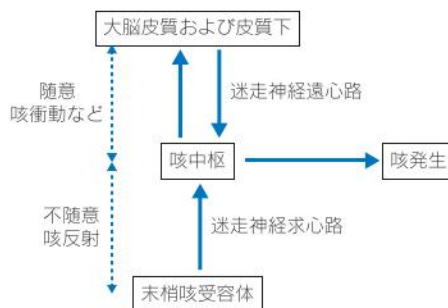


図 1 咳嗽の発生機序

[日本呼吸器学会咳嗽・喀痰の診療ガイドライン 2025 作成委員会（編）：咳嗽・喀痰の診療ガイドライン 2025，メディカルレビュー社，p6，2025]

c 中枢性鎮咳薬

中枢性鎮咳薬は麻薬性と非麻薬性に分類される，ともに延髄孤束核にある咳中枢を抑制することで鎮咳作用を示す。

麻薬性中枢性鎮咳薬は，オピオイド受容体を活性化し，咳中枢を抑制することで鎮咳作用を示す。高い鎮咳効果が期待できる反面，便秘，眠気，嘔気，呼吸抑制作用などの副作用に注意が必要となる。これらの鎮咳薬は，重篤な呼吸抑制や肝機能異常を有する患者，喘息発作中の患者，慢性肺疾患に続発する心不全患者には禁忌である。一方，非麻薬性中枢性鎮咳薬も，咳中枢の抑制により鎮咳作用を示すがオピオイド受容体とは異なる受容部位に結合する。鎮咳効果は麻薬性鎮咳薬に及ばないが，副作用が少なく，耐性や依存性がないという利点がある^{4,5)}。

d 末梢性鎮咳薬

選択的 P2X3 受容体拮抗薬である，gefapixant（リフヌア[®]）は，気道の迷走神経の C 線維上にみられる P2X3 受容体を介した細胞外 ATP シグナル伝達の遮断により鎮咳作用を示す薬剤で⁶⁾，難治性の慢性咳嗽に対して使用される。副作用には，特に味覚関連（味覚不全，味覚消失，味覚減退，味覚障害）が 6 割以上と高頻度に発現する。味覚関連の有害事象に関しては基本的には投与中止により可逆性に改善する。

3 喀痰調整薬

a 喀痰の発生機序

喀痰とは，下気道で過剰に産生された分泌物が，口腔内を経て体外に排出されたものの総称である。粘液線毛輸送系による生理的排泄（粘液線毛クリアランス）の処理能力を超えた分泌物の気道内貯留が咳受容体を刺激し，咳嗽により喀痰として喀出される（咳ク